病变会达到肌层,主要支配平滑肌的神经麻痹

（4）重度 UC 并发**中毒性巨结肠**（麻痹性肠梗阻）

钡剂阻塞肠道→加重梗阻

①诱因：**钡灌肠**、**低钾、抗胆碱药、阿片药**如吗啡　肠道蠕动↓→胀气

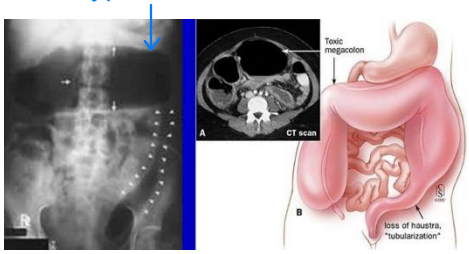
②表现：**全腹压痛膨隆、肠鸣音↓、明显毒血症（高热、血 WBC 显著↑）**

③首选 X 线：结肠扩张、肠壁变薄、结肠袋形消失，**横结肠**最严重（横死）

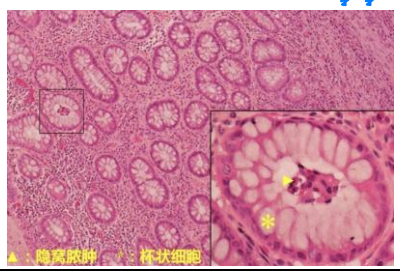
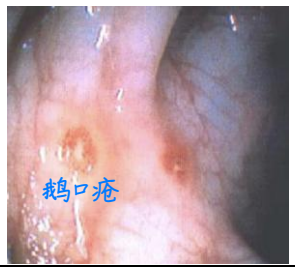
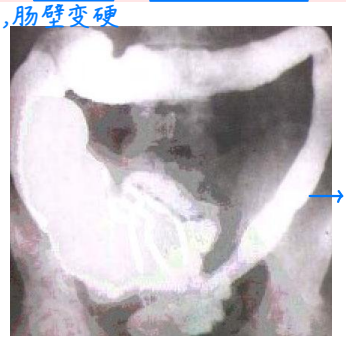
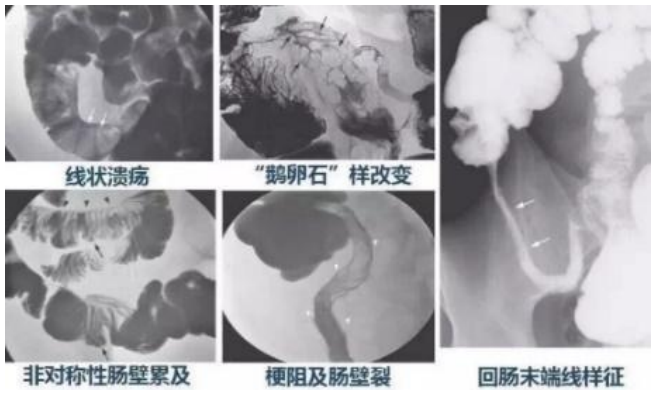
不能用镜子看,易穿孔

肠道黏膜屏障变薄,免疫功能↓→大量细菌发生菌群移位→毒素入血(类似败血症)

胀大的横结肠



三、UC VS CD

	溃疡性结肠炎 UC	**克罗恩病 CD**
好发部位	**直肠及乙状结肠**	**回肠末端及邻近结肠**
病变分布	**连续、弥漫性**	**节段、跳跃性**
主要症状	**左下**腹痛、**黏液脓血便、里急后重** 腹痛→便意→便后缓解 肠结核 (做鸡亏又接客) 细菌性痢疾	**右下**腹痛、腹部包块 非干酪肉芽肿 腹痛→进食→疼痛加重 容易肠梗阻 胃溃疡：进食→疼痛→缓解 十二指肠溃疡：疼痛→进食→缓解
结肠镜	**浅**溃疡 隐窝脓肿，杯状细胞↓，中心性肠腔狭窄  ▲：隐窝脓肿　↑：杯状细胞	早期鹅口疮、之后**纵**行裂隙状深溃疡 **鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿**，偏心性肠腔狭窄 VS 结节病:支气管镜见黏膜结节呈铺路石样,非干酪性肉芽肿  鹅口疮 
钡灌肠 胶原纤维增生收缩,瘢痕变硬	可有铅管征（肠管缩短、管腔狭窄、肠壁变硬、结肠袋形消失） 本质就是麻痹性肠梗阻,若肠壁硬,就不会被撑大 注意：铅管征与中毒性巨结肠不共存 已出现纤维化,肠壁变硬  →铅管征	线样征、鹅卵石征、铺路石征 钡剂流入纵行裂隙状深溃疡  线状溃疡　"鹅卵石"样改变 非对称性肠壁累及　梗阻及肠壁裂　回肠末端线样征 CD是深溃疡→肉芽组织过多增生→肠梗阻常见
并发症	①**中毒性巨结肠（重度 UC 最常见）：易急性穿孔**　黏膜下层富含血管 ②**癌变**、出血、梗阻　不常见,浅溃疡,纤维修复少 大肠癌　癌前病变:找腺瘤,息肉病,慢性血吸虫,UC,CD	①**肠梗阻（最常见）**　肠结核、结核性腹膜炎、CD ②腹腔或肛周脓肿：充分引流、甲硝唑和喹诺酮类 ③**瘘管**　肠道内革兰阴性杆菌、厌氧菌多 ④癌变、出血、急性穿孔

UC是浅溃疡,一般不会穿孔,一旦发生了穿孔说明并发了中毒性巨结肠(病变已达到了肌层,而且此时胀气严重,容易胀破)

病例题考UC并发中毒性巨结肠

患者长期黏液脓血便,里急后重,左下腹痛,有钡灌肠/低钾/抗胆碱药/阿片药的情况后发生了全腹膨隆压痛,肠鸣音减弱消失,血中白细胞显著上升,寒战高热。接下来选择的检查?(C)

A 结肠镜　B 钡灌肠　C X线　D …